

ICLS救急時計 スマホ版 かんたんガイド

ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.1.1-html (スマホ) (2026-10-06 版)

スマホで開くと、パソコンとは並びかたが違います。このガイドは、**スマホの実際の画面**に番号を付けて、どこを押すかを示します。

※ スマホで使うのは、**練習用**です。実際の患者さんの情報は入れないでください。本番の記録は、電子カルテ端末で取ります。練習用ページでは、画面の上にオレンジ色の帯が出ます。※ 色で意味を区別している箇所があります。カラーで印刷してください。

開きかた

1. 掲示のQRコードを、スマホのカメラで読み取ります (iPhone もAndroid も、カメラをかざすだけです)
2. 出てきたリンクを開きます
3. 開いたら、画面のどこかを一度タップします。音声が届くようになります
4. スマホは、縦向きでも横向きでも使えます。縦向きは1列、横向きは2列に並びます

縦向きの画面：上から下へ、指で動かして使います

画面の一番上には、**時計の帯**が付いています。下へスクロールしても、時計は上に残ります。

① ② ③ ④ ⑤

ID: 0000000 氏名: テスト 太郎

現在時刻: 14:36:01 CPR経過: 05:50 サイクル残り: 00:25 アドレナリン経過: 04:55 (目標4分) 状態: CPR実施中

CPR管理

CPR 開始

CPR 終了

CPA 確認

心拍 再開 (ROSC)

リズム確認

VF ● pVT

● PEA ● 心静止

● 洞調律

除細動 (Shock)

除細動: 1回

H's & T's (左:H系 右:T系)

■ 低血流量(Hv) ■ 緊張性気胸(Tp)

■ 低酸素(Hx) ■ タンポナーデ(Tt)

■ アシドーシス(H⁺) ■ 毒物/薬物(Tx)

■ 低/高K(K⁺) ■ 肺血栓塞栓(PE)

■ 低体温(Ht) ■ 冠動脈血栓(ACS)

① 上：患者欄・時計・CPR管理

1. 患者ID・氏名 (あとから入れても大丈夫)
2. 時計の帯 (常に上に出来ます)
3. CPR開始
4. CPR終了
5. 心拍 再開 (ROSC)

現在時刻: 14:36:01 CPR経過: 05:50 サイクル残り: 00:25 アドレナリン経過: 04:55 (目標4分) 状態: CPR実施中

心拍 再開 (ROSC)

リズム確認

① VF ● pVT

● PEA ● 心静止

● 洞調律

② 除細動 (Shock)

除細動: 1回

H's & T's (左:H系 右:T系)

③ ■ 低血流量(Hv) ■ 緊張性気胸(Tp)

■ 低酸素(Hx) ■ タンポナーデ(Tt)

■ アシドーシス(H⁺) ■ 毒物/薬物(Tx)

■ 低/高K(K⁺) ■ 肺血栓塞栓(PE)

■ 低体温(Ht) ■ 冠動脈血栓(ACS)

薬剤投与

アドレナリン アミオダロン (アンカロン)

1mg IV/IO 3-5分毎 初回300mg → 追加150mg 除細動後 未投与

最終 14:31:06

リドカイン (キシロカイン) マグネシウム (マグネゾール)

1-1.5mg/kg アミオダロン代替 未投与 2g IV TdP/低Mg 未投与

炭酸水素Na (メイロン) カルシウム (カルチコール)

1mEq/kg 高K/TCA/アンドロース 最終 14:33:11 塩化Ca 1g 高K/CCB中毒 未投与

ドーパミン ノルアドレナリン

5-20μg/kg/min ROSC後昇圧 未投与 0.1-0.5μg/kg/min ROSC後昇圧 未投与

生理食塩水 細胞外液 (ソラクト)

輸液 未投与 輸液 未投与

処置・手技

除細動器装着 静脈路確保

気管挿管 経皮パージング

声門上気道デバイス 超音波(FOCUS)

12誘導心電図 血液ガス採取

ECPR開始

タイムライン

14:36:01 CPR経過 この記録を再読み込み

② 下へ：リズム・除細動

1. リズム確認 (VF/pVT/PEA/心静止/洞調律)
2. 除細動 (Shock)
3. H's & T's (チェックで「疑い」、外すと「除外」)

現在時刻: 14:36:02 CPR経過: 05:51 サイクル残り: 00:24 アドレナリン経過: 04:56 (目標4分) 状態: CPR実施中

薬剤投与

② アドレナリン アミオダロン (アンカロン)

1mg IV/IO 3-5分毎 初回300mg → 追加150mg 除細動後 未投与

最終 14:31:06

リドカイン (キシロカイン) マグネシウム (マグネゾール)

1-1.5mg/kg アミオダロン代替 未投与 2g IV TdP/低Mg 未投与

炭酸水素Na (メイロン) カルシウム (カルチコール)

1mEq/kg 高K/TCA/アンドロース 最終 14:33:11 塩化Ca 1g 高K/CCB中毒 未投与

ドーパミン ノルアドレナリン

5-20μg/kg/min ROSC後昇圧 未投与 0.1-0.5μg/kg/min ROSC後昇圧 未投与

③ 生理食塩水 細胞外液 (ソラクト)

輸液 未投与 輸液 未投与

処置・手技

除細動器装着 静脈路確保

気管挿管 経皮パージング

声門上気道デバイス 超音波(FOCUS)

12誘導心電図 血液ガス採取

ECPR開始

タイムライン

14:36:02 CPR経過 この記録を再読み込み

③ さらに下へ：薬剤

1. アドレナリン
2. そのほかの薬のボタン
3. 生理食塩水・細胞外液 (ソラクト)

現在時刻	CPR経過	サイクル残り	アドレナリン経過 (目標4分)	状態
14:36:02	05:51	00:24	04:56	CPR実施中

輸液	輸液
未投与	未投与

1

処置・手技

除細動器装着	静脈路確保
気管挿管	経皮ペースング
声門上気道デバイス	超音波(FOCUS)
12誘導心電図	血液ガス採取
ECPR開始	

タイムライン

14:30:01	CPA確認	この記録を取り消す
14:30:11 (+00:00)	CPR開始	この記録を取り消す
14:30:16 (+00:05)	リズム: VF	この記録を取り消す
14:30:26 (+00:15)	除細動 #1 (VF) → 直ちにCPR再開	この記録を取り消す
14:31:06 (+00:55)	アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pVTは2回目ショック後推奨 (現在1回)	この記録を取り消す
14:32:06 (+01:55)	メモ: 家族到着	この記録を取り消す
14:32:21 (+02:10)	静脈路確保	この記録を取り消す
14:32:26 (+02:15)	— 2分経過 —	リズムチェック / パルスチェック
14:33:11 (+03:00)	炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス	この記録を取り消す
14:34:26 (+04:15)	— 2分経過 —	リズムチェック / パルスチェック
14:35:01 (+04:50)	気管挿管	この記録を取り消す

④ 処置・手技

1. 処置・手技のボタン (挿管・静脈路確保など)

現在時刻	CPR経過	サイクル残り	アドレナリン経過 (目標4分)	状態
14:36:03	05:52	00:23	04:57	CPR実施中

14:30:16 (+00:05)	リズム: VF
14:30:26 (+00:15)	除細動 #1 (VF) → 直ちにCPR再開
14:31:06 (+00:55)	アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pVTは2回目ショック後推奨 (現在1回)
14:32:06 (+01:55)	メモ: 家族到着
14:32:21 (+02:10)	静脈路確保
14:32:26 (+02:15)	— 2分経過 —
14:33:11 (+03:00)	炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス
14:34:26 (+04:15)	— 2分経過 —
14:35:01 (+04:50)	気管挿管

2

記録を書き出す

新しい症例

メモ窓

音 ON

設定

症例の管理 v1.1.1-html

記録: このブラウザ内 保存期間: 7日 保存済み

※ 表示は目安です。臨床判断は医師が行ってください

⑤ 一番下：タイムラインとボタン

1. タイムライン (やったことが並びます)
2. 下のボタン: 記録を書き出す / 新しい症例 / メモ窓 / 音 / 設定 / 症例の管理

現在時刻	CPR経過	サイクル残り	アドレナリン経過 (目標4分)	状態
14:36:11	06:00	00:15	05:05	CPR実施中

2

14:30:01

CPA確認

この記録を取り消す

14:30:11 (+00:00)

CPR開始

この記録を取り消す

14:30:16 (+00:05)

リズム: VF

この記録を取り消す

14:30:26 (+00:15)

除細動 #1 (VF) → 直ちにCPR再開

この記録を取り消す

14:31:06 (+00:55)

アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pVTは2回目ショック後推奨 (現在1回)

この記録を取り消す

14:32:06 (+01:55)

メモ: 家族到着

この記録を取り消す

14:32:21 (+02:10)

静脈路確保

この記録を取り消す

14:32:26 (+02:15)

— 2分経過 —

リズムチェック / パルスチェック

14:33:11 (+03:00)

炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス

この記録を取り消す

14:34:26 (+04:15)

— 2分経過 —

リズムチェック / パルスチェック

14:35:01 (+04:50)

気管挿管

この記録を取り消す

14:36:11 (+06:00)

血液ガス採取

この記録を取り消す

記録を書き出す

新しい症例

メモ窓

音 ON

⑥ 押し間違えたとき

1. 行の「この記録を取り消す」を押します。スマホでは、最初から全部の行に出ています。押すと、その場で取り消されます
2. 取り消した行は、打消線に残ります。間違えたときは、同じ行の「取消を戻す」で戻せます

横向きの画面：2列に並びます

患者 ID	氏名
0000000	テスト 太郎

現在時刻	CPR経過	サイクル残り	アドレナリン経過 (目標4分)	状態
14:36:14	06:03	00:12	05:08	CPR実施中

CPR管理	薬剤投与
CPR 開始	アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 最終 14:31:06
CPR 終了	アミオダロン (アンカロン) 初回300mg → 追加150mg 除細動後 未投与
CPA 確認	リドカイン (キシロカイン) 1-1.5mg/kg アミオダロン代替 未投与
心拍 再開 (ROSC)	マグネシウム (マグネゾール) 2g IV TdP/低Mg 未投与
リズム確認	炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス 最終 14:33:11
	カルシウム (カルチコール) 塩化Ca 1g 高K/CCB中毒 未投与

横向き (実際の画面)

1. 時計の帯 (常に上に出来ます)
2. 左の列: CPR管理 → リズム確認 → 除細動 → H's & T's (下へスクロール)
3. 右の列: 薬剤投与 → 処置・手技 (下へスクロール)。タイムラインは、2列の下に出ます

基本の流れ

1. 心停止を認識したら、真っ先に「CPR開始」を押します。これが全部の基準時刻になります
2. やったことのボタンを押します（リズム、除細動、薬、処置）。押した瞬間の時刻で、自動で記録されます
3. CPRをやめたら「CPR終了」（心拍が戻ったときは「ROSC」。ROSCが終了を兼ねます）を押します
4. 下の「記録を書き出す」を開いて、「クリップボードにコピー」を押します。ほかのアプリに貼り付けられます
5. 次の患者さんのときは、書き出しのあとで「新しい症例」を押します

CPR開始とCPR終了は、セットです。押し忘れると、時計が動き続け、2分ごとの音声も流れ続けます。

時計の色の意味（アドレナリンは緑のうちに入れる、サイクル残りは赤が「もうすぐ」）は、パソコン版の「かんたん操作マニュアル」に載っています。

スマホで使うときの注意

- 練習用です。実際の患者さんの情報は、入力しないでください。
- 記録は、このスマホのブラウザの中に保存されます（外部には送られません）。別のスマホやパソコンからは見えません。保存期間は7日です
- 画面を閉じたり、スマホが止まったりしても、開き直すと「前回の記録が残っています。続きから開きますか？」と出ます。「はい」で元に戻ります
- CPR開始で、画面が暗くならないようにします（ブラウザが対応している場合）
- 音声が届かないときは、スマホの音量とマナーモードを確かめて、画面を一度タップします。日本語の音声がないスマホでは、音声の代わりに、ピープ音が鳴ります
- プライベートモード（シークレット）では使いません。閉じると、記録が消えます

困ったとき

こうなった	こうする
操作ボタンが見えない	画面を上へ戻します。時計の帯の下に、CPR管理のボタンがあります
文字が小さい	スマホを横向きにするか、ブラウザの「拡大」で調整します
音声が届かない	画面を一度タップします。音量とマナーモードも確かめます
時計が止まらない	「CPR終了」（心拍が戻ったときは「ROSC」）の押し忘れです。いま押せば止まります
記録が消えた	ブラウザの閲覧データを消したか、プライベートモードで開いていた可能性があります

メモと書き出し

患者ID

0000000

氏名

テスト 太郎

現在時刻

14:36:12

CPR経過

06:01

サイクル残り

00:14

アドレナリン経過
(目標4分)

05:06

状態

CPR実施中

CPR管理

CPR 開始

CPR 終了

CPA 確認

心拍 再開 (ROSC)

リズム確認

☐ VF
☐ pVT

☐ PEA
☐ 心静止

メモ

×

家族到着

家族へ説明

DNAR確認

他院より情報あり

蘇生中止を相談

定型文を編集

メモ窓

- メモ窓。下の「メモ窓」ボタンで開きます（スマホでは、最初は閉じています）
- 定型文のボタン。押すだけで記録されます
- 自由に書く欄。改行は、キーボードの改行キーです。記録するには、「Enter」を押します

記録の書き出し

- ☒ 取り消した記録を除く ☐ 経過記録（1行形式）

- ☐ サマリ（見出し+本文）

1

14:30:01 CPA確認
 14:30:11 (+00:00) CPR開始
 14:30:16 (+00:05) リズム: VF
 14:30:26 (+00:15) 除細動 #1 (VF) → 直ちに CPR再開
 14:31:06 (+00:55) アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pVTは2回目ショック後推奨（現在1回）
 14:32:06 (+01:55) メモ: 家族到着
 14:32:21 (+02:10) 静脈路確保
 14:32:26 (+02:15) — 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック
 14:33:11 (+03:00) 炭酸水素Na（メイロン） 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス
 14:34:26 (+04:15) — 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック
 14:35:01 (+04:50) 気管挿管
 14:36:11 (+06:00) 血液ガス採取

- 2
- クリップボードにコピー CSVで保存

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ 低酸素(Hx) | ☐ タンポナーデ(Tt) |
| ☐ アシドーシス(H ⁺) | ☐ 毒物/薬物(Tx) |
| ☐ 低/高K(K ⁺) | ☐ 肺血栓塞栓(PE) |
| ☐ 低体温(Ht) | ☐ 冠動脈血栓(ACS) |

記録の書き出し

- プレビュー（書き直せます。コピーされるのは、書き直したあとの内容です）
- 「クリップボードにコピー」。そのあと、貼り付けたいアプリを開いて、貼り付けます

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。